# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## ESCALA DE CAPITAL SOCIAL COGNITIVO (ECSC-5)

Eje IV: Recursos y Bienestar • Evaluación de Redes de Apoyo y Tejido Social (Campo-Arias et al., 2024)

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

| | |
|---|---|
| **Nombre Oficial (Español)** | Escala de Capital Social Cognitivo - Versión Breve de 5 ítems (ECSC-5). |
| **Nombre Original** | Cognitive Social Capital Scale (CSCS-5; Campo-Arias, Caballero-Domínguez & Pedrozo-Pupo, 2024). |
| **Autores Originales** | Adalberto Campo-Arias, Carmen Cecilia Caballero-Domínguez y John Carlos Pedrozo-Pupo. |
| **Ámbito Geográfico** | Validada psicométricamente en población adulta colombiana e hispanohablante. |
| **Eje Clínico y Constructo** | Eje IV: Recursos y Bienestar. Percepción subjetiva de reciprocidad, confianza y apoyo vecinal. |
| **Tipo de Instrumento** | Escala de autoinforme ultracorta de cribado social y comunitario. |
| **Composición de Reactivos** | 5 ítems directos evaluados en escala Likert graduada de 4 opciones (0 a 3 puntos). |
| **Población y Rango** | Adultos y ancianos (18 a 76 años) en contextos clínicos, de atención primaria y comunitarios. |
| **Tiempo de Administración** | 1 a 3 minutos de cumplimentación ágil. |
| **Régimen de Licencia** | Acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CAPITAL SOCIAL COGNITIVO COMO FACTOR PROTECTOR

En las ciencias de la salud y la psicología comunitaria, el capital social constituye un determinante psicosocial primario del bienestar:

1. **Diferenciación Estructural vs. Cognitiva:** Mientras el capital social estructural cuantifica la pertenencia formal a organizaciones, el **capital social cognitivo** capta la cualidad subjetiva del tejido social: confianza interpersonal, normas de reciprocidad y valores compartidos en el microentorno de vida.
2. **Modulador del Estrés y la Salud Mental:** Diversas investigaciones epidemiológicas (De Silva et al., 2005) demuestran que niveles robustos de capital social cognitivo amortiguan el impacto de sucesos vitales estresantes, reduciendo la incidencia de trastornos afectivos, cuadros de ansiedad generalizada y soledad no deseada.
3. **Cribado Rápido y Factibilidad:** Frente a baterías extensas e inconsistentes, la ECSC-5 aísla los cinco reactivos nucleares que concentran la mayor capacidad discriminante del tejido comunitario.

### 3. COMPOSICIÓN DE REACTIVOS Y FORMATO DE RESPUESTA

| Ítem | Enunciado del Reactivo (Castellano) | Carga Factorial ($\lambda$) |
|---|---|---|
| **1** | Las personas de este vecindario son unidas y generalmente se conocen entre sí. | $\lambda = 0.43$ (Comunalidad 0.18) |
| **2** | Si tuviera que pedir prestado dinero en caso de emergencia, podría pedírselo a un vecino. | $\lambda = 0.69$ (Comunalidad 0.48) |
| **3** | Se puede confiar en las personas de este vecindario. | $\lambda = 0.72$ (Comunalidad 0.53) |
| **4** | Si estuviera enfermo/a, podría contar con mis vecinos para que hicieran compras por mí. | $\lambda = 0.80$ (Comunalidad 0.64) |
| **5** | Las personas en este vecindario comparten los mismos valores. | $\lambda = 0.69$ (Comunalidad 0.47) |

Formato de respuesta: 0 = Totalmente en desacuerdo, 1 = En desacuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = Totalmente de acuerdo.

# PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN COMUNITARIA

## 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y ESTRUCTURA FACTORIAL EN ADULTOS

El estudio de validación psicométrica (Campo-Arias et al., 2024; $N = 700$ adultos, 68% mujeres, 18-76 años) evidenció indicadores sobresalientes:

| Propiedad Psicométrica | Coeficiente / Métrica | Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica |
|---|---|---|
| **Consistencia Interna** | Alfa de Cronbach = 0.79 | Excelente cohesión de los 5 reactivos; superó ampliamente la versión de 7 ítems ($\alpha = 0.56$). |
| **Fiabilidad Compuesta** | Omega de McDonald = 0.80 | Estabilidad robusta ante la no equivalencia tau de las cargas factoriales. |
| **Estructura Factorial** | Unidimensional estricta | Autovalor inicial de 2.79, explicando el 55.88% de la varianza total acumulada. |
| **Bondad de Ajuste (CFA)** | CFI = 0.97 • TLI = 0.94 | Ajuste confirmatorio óptimo ($\chi^2 = 35.14$, $gl = 5$, RMSEA = 0.09, SRMR = 0.03). |
| **Validez de Contenido** | Adecuación muestral KMO = 0.77 | Prueba de esfericidad de Bartlett altamente significativa ($p < 0.001$). |

## 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

• **Puntuación por Ítem:** Cada reactivo puntúa de 0 a 3 según el grado de acuerdo expresado por el participante.
• **Cálculo de la Puntuación Total ECSC-5:** Se realiza la sumatoria lineal simple de los 5 reactivos:

$$\text{Puntuación Total ECSC-5} = \sum_{i=1}^{5} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango escalar: } 0 \text{ a } 15 \text{ puntos})$$

• **Direccionalidad Teórica:** A mayor puntuación, mayor percepción de capital social cognitivo, soporte vecinal y confianza compartida.
• **Manejo de Omisiones:** Dado que consta de sólo 5 ítems breves, la presencia de 1 ítem omitido invalida el cómputo directo; se recomienda su re-administración inmediata.

## 6. BAREMOS NORMATIVOS, ESTRATIFICACIÓN Y PUNTOS DE CORTE

| Estratificación | Puntos ECSC-5 | Nivel | Significado Clínico y Comunitario (Campo-Arias et al.) |
|---|---|---|---|
| **Capital Social Alto** | 11 a 15 puntos | Percentil $> 75$ | Tejido de confianza sólido; reciprocidad vecinal activa y red de contención protectora. |
| **Capital Social Moderado** | 7 a 10 puntos | Percentil 25 - 75 | Integración vecinal básica con áreas específicas de desconfianza o apoyo condicional. |
| **Capital Social Bajo** | **4 a 6 puntos** | **Percentil 10 - 25** | **Alerta comunitaria** aislamiento relacional, baja reciprocidad y vulnerabilidad ante estrés. |
| **Aislamiento Crítico** | **0 a 3 puntos** | **Percentil < 10** | **Desconexión severa** anomia barrial, desconfianza absoluta y ausencia de redes de auxilio. |

**PUNTO DE CORTE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (ECSC-5 <= 6 PUNTOS):**
Las puntuaciones de 6 o menos reflejan un entorno inmediato percibido como hostil o fragmentado. En pacientes con patología afectiva o enfermedades crónicas, esta condición predice peor adherencia terapéutica, mayor riesgo de recaídas y sensación de desamparo frente a contingencias cotidianas.

# APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

## 7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y COMUNITARIA

**PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS COMUNITARIOS:**

• **Paso 1 (Cribado en Consulta Inicial):** Administrar la ECSC-5 junto con inventarios de síntomas en personas que enfrentan duelo, transiciones vitales o patología somática crónica.

• **Paso 2 (Triaje según Puntuación):**

• *ECSC-5* $\geq 11$ *pts:* Red de soporte intacta. Fomentar el uso de vínculos barriales como coterapeutas naturales.

• *ECSC-5 7 a 10 pts:* Apoyo vecinal parcial. Mapear figuras específicas de confianza antes de indicar intervenciones complejas.

• *ECSC-5* $\leq 6$ *pts:* Alerta roja psicosocial. Priorizar la vinculación con servicios sociales comunitarios, centros de día o grupos de autoayuda; el paciente carece de sostén instrumental ante crisis.

• **Paso 3 (Monitorización de Impacto):** Reevaluar semestralmente para constatar si las intervenciones psicosociales restituyeron el sentido de pertenencia comunitaria.

## 8. CASO ILUSTRATIVO: EVALUACIÓN DE SOLEDAD Y RIESGO DE DEPRESIÓN EN ADULTO MAYOR

**Identificación:** Mujer de 67 años, viuda reciente, residente en un barrio urbano periférico, derivada a atención primaria por insomnio terminal, astenia marcada y rumiación pesimista tras mudarse de vivienda.

**Evaluación Psicométrica Inicial:**

• PHQ-9 = 14 puntos (Sintomatología depresiva moderada).

• **Puntuación ECSC-5 = 3 / 15 puntos** (Nivel de Aislamiento Crítico; percentil $< 10$).

• *Desglose de Reactivos:* Ítem 1 (Unión barrial) = 1; Ítem 2 (Auxilio económico) = 0; Ítem 3 (Confianza en vecinos) = 1; Ítem 4 (Apoyo en enfermedad) = 0; Ítem 5 (Valores compartidos) = 1.

**Interpretación Psicosocial:** La paciente percibe una ruptura traumática de sus redes de contención histórica tras el traslado de barrio, sintiéndose incapaz de solicitar auxilio en caso de indisposición médica.

**Plan Terapéutico Integrado:** Activación conductual articulada con el centro comunitario barrial (taller de actividad física adaptada y club de lectura) y coordinación con el servicio de voluntariado local. A los 4 meses, la reevaluación mostró una ECSC-5 de 9/15 y una remisión del PHQ-9 a 5 puntos.

## 9. ALERTAS DE SEGURIDAD, DEONTOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

**NO ES DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL:**
La ECSC-5 no diagnostica patología mental, sino un determinante psicosocial del entorno; no sustituye la evaluación clínica formal.

**SESGO POR PARANOIA O DEPRESIÓN:**
Cuadros paranoides o depresivos graves pueden sesgar negativamente las respuestas; corroborar con observación objetiva del entorno.

## 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS


1. Campo-Arias, A., Caballero-Domínguez, C. C., & Pedrozo-Pupo, J. C. (2024). Internal consistency and dimensionality assessment of the Cognitive Social Capital Scale among Colombian adults. *Medicina Clínica y Social*, 8(1), 75-83. https://doi.org/10.52379/mcs.v8i1.363
2. De Silva, M. J., McKenzie, K., Harpham, T., & Huttly, S. R. (2005). Social capital and mental illness: A systematic review. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 59(8), 619-627.
3. Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., & Woolcock, M. (2004). *Measuring social capital: An integrated questionnaire*. World Bank Working Paper No. 18. The World Bank.
4. Harpham, T., Grant, E., & Thomas, E. (2002). Measuring social capital: tool or toy? *Health Policy and Planning*, 17(1), 106-111.